รายงานการประชุม
คณะผู้วิจัยโครงการ TN-iLTC (Thailand Integrated Long-Term Care Framework)
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/บทบาทในโครงการ
1	ผศ.นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส	หัวหน้าโครงการ (ประธาน)
2	รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ	ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
3	ดร.รุ่งนภา คำผาง	คณะผู้วิจัย (ประชุมออนไลน์)
4	พญ.ณัฐณิชา มานะบริบูรณ์	คณะผู้วิจัย (ผู้รับผิดชอบ WP1)
5	นพ.นนทกร ศิริวัฒนสาธร	คณะผู้วิจัย (ผู้รับผิดชอบ WP3) / ผู้จดรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

1.1 ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการจาก สวรส.

สวรส. ส่งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (reviewer) กลับมาแล้วตามกระบวนการปกติ หากคณะผู้วิจัยตอบชี้แจงและปรับแก้เรียบร้อย จะเข้าสู่ขั้นตอนลงนามรับทุนต่อไป ข้อมูลที่ สวรส. แจ้งล่าสุดมีดังนี้

- โครงการอยู่ในรายการของ สวรส. เป็นโครงการลำดับที่ 4 ด้าน long-term care (LTC eligibility criteria in Thailand) ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน
- วงเงินที่ระบุคือ 900,000 บาท สูงกว่าที่ขอไป (ประมาณ 670,000 บาท) ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการเพิ่มงบประมาณเพื่อรองรับการสำรวจความคิดเห็นผู้ให้บริการตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ

- คะแนนโดยสรุปจากผู้ทรงคุณวุฒิ 66 คะแนน โดยระยะเวลาดำเนินการ “เหมาะสม” และประสบการณ์ของคณะผู้วิจัย “เพียงพอ”

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ตอบชี้แจงความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

– ไม่ได้พิจารณาในที่ประชุมครั้งนี้ (รายงานการประชุมวันที่ 24 กันยายน 2569 เวียนให้คณะผู้วิจัยแล้ว) –

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ทบทวนความเข้าใจ flow ของ Work Package

นพ.นนทกร นำเสนอแผนภาพ flow ที่สรุปจาก infographic ของประธาน เพื่อให้เข้าใจตรงกัน โดยมี WHO Global Standards for Long-Term Care เป็นฐานหลักที่ใช้เทียบกับทั้ง 3 WP ดังนี้

- **WP1** นำหลักฐานของประเทศไทย (เช่น รายงาน UHC/IMC/LTC ของหน่วย และรายงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) มา map กับมาตรฐาน ได้เป็น matrix mapping เพื่อนำเข้าสู่ WP2
- **WP2** modified Delphi ให้ผู้เข้าร่วมให้คะแนน priority และ feasibility ของแต่ละมาตรฐาน
- **WP3** ทบทวน 3 คำถาม (eligibility criteria, transition จาก IMC สู่ LTC และ non-cancer palliative triggers) พัฒนาเป็น prototype แล้วนำเข้า policy lab กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประมาณ 30 ท่าน เพื่อสรุปเป็น policy option

ที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- WP1 และ WP2 เป็นการประเมินสถานการณ์ของประเทศ (country self-assessment) ว่าระบบบริการ LTC ของไทยอยู่ระดับใดเมื่อเทียบกับ WHO Standards โดยมีเครื่องมือให้คะแนน 5 ระดับ จากนั้นเข้าสู่ modified Delphi 2 รอบ คือ รอบแรกส่งให้ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนน และรอบที่สองนำเสนอผลรวม

ให้ผู้เชี่ยวชาญปรับคะแนนของตนได้ ผลลัพธ์ของ WP1–2 คือ ระดับความพร้อม (readiness) ของประเทศไทย

- WP3 เป็นงานที่แยกจาก WP1–2 เนื่องจาก WHO Standards ระบุเพียงว่าต้องมี eligibility criteria แต่ไม่ได้ระบุว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมคืออะไร WP3 จึงเริ่มจาก systematic review เพื่อระบุเครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผู้รับบริการเข้าสู่ LTC (หรือ transition จาก IMC สู่ LTC) แล้วพัฒนาเป็น prototype ผ่านการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกในประเทศไทย ก่อนนำไปรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder consultation ไม่ใช่ Delphi)
- ดังนั้นในแผนภาพไม่ควรมีลูกศรจาก modified Delphi ไปสู่ prototype เพราะเป็นคนละส่วนกัน ส่วนอื่นของ flow ถูกต้อง ทั้งนี้ WP1 และ WP3 ควรดำเนินการคู่ขนานกัน เนื่องจากต้องใช้หลักฐานจากทั้งสองส่วนประกอบการร่าง policy option
- job description ของ WP1 และ WP3 ที่ผู้รับผิดชอบเขียนไว้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม เห็นชอบ flow ของ Work Package โดยแก้ไขแผนภาพให้ WP1–2 และ WP3 เป็นสายงานแยกกัน (ตัดลูกศรจาก modified Delphi ไปสู่ prototype)

3.2 ผลการ explore WP1

พญ.ณัฐณิชา นำเสนอผลการ explore เบื้องต้น สรุปได้ดังนี้

- **แนวทางของ WHO ที่เกี่ยวข้อง** ได้แก่ (1) ICOPE ซึ่งเป็นแนวทางการดูแลทั่วไป ไม่เกี่ยวกับ LTC โดยตรง (2) Framework ปี 2021 (six building blocks) ซึ่ง Global Standards ฉบับร่างปัจจุบัน build on และเป็น framework ที่รายงานของรามาธิบดีใช้ (3) LTC package for UHC ปี 2023 ซึ่งเชื่อม LTC กับ UHC และเป็นกรอบที่รายงานของ SiHP ใช้ (intervention แบ่งเป็น health care, palliative care และ social care and support)

- **โครงสร้างของ Global Standards ฉบับร่าง** ประกอบด้วย 7 components, 34 standards, 106 quality statements และ indicative data points โดยคาดว่า 7 components ไม่น่าเปลี่ยน 34 standards อาจเปลี่ยนเล็กน้อย 106 quality statements มีโอกาสเปลี่ยน ส่วน indicative data points ยังไม่ได้ข้อสรุป
- **การเทียบ 7 components กับ framework ปี 2021** ส่วนบริการ ได้แก่ home and community-based care, LTC facility และ support for unpaid carers ส่วนที่มาจาก framework ปี 2021 ได้แก่ workforce, financing, governance และ quality monitoring ส่วนที่ฉบับร่างตัดออกคือ innovation และ research
- **รายงานของ SiHP (2025)** ครอบคลุมทั้ง IMC และ LTC จัดทำตามที่ UHC Conference มอบหมาย ใช้ข้อมูล LTC ของ สปสช. ปี 2023–2025 และสัมภาษณ์ภาคสนาม 3 จังหวัด พบว่าประเทศไทยมีข้อมูลเพียงบาง component ความท้าทายหลักคือด้านงบประมาณ
- **รายงานของรามาธิบดี (2026)** สปสช. เป็นผู้มอบหมาย ใช้ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสัมภาษณ์ภาคสนาม 4 จังหวัด ใช้ six building blocks ปี 2021 เน้นวิเคราะห์ design–implementation gap และ community-based มากกว่า facility-based และไม่ได้ครอบคลุม innovation และ research
- **ผลการ map เบื้องต้น (ใช้ AI ช่วย)** จาก 7 components มีข้อมูลแน่นอนประมาณ 3 components ที่เหลือต้องขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ช่องว่างหลัก ได้แก่ facility-based care, unpaid carers (map ได้บางส่วน ยังขาด carer rights และ social protection), governance (ยังขาด licensing, regulation และ rights protection) และ monitoring (ยังขาด inspection, compliance และ public reporting)

- **เอกสารที่ต้องทบทวนเพิ่ม** (1) การปรับการเบิกจ่าย LTC ของ สปสช. เมื่อเดือนเมษายน (ด้าน financing) และ (2) เอกสารใหม่เรื่องการจ่ายค่าตอบแทน caregiver เมื่อเดือนกันยายน (ด้าน workforce และ financing)

ประเด็นอภิปราย

- **ความไม่แน่นอนของฉบับร่าง** Global Standards เป็น consultation draft ที่เพิ่งจัดทำในปีนี้ ปิดรับความเห็นวันที่ 30 และระบุว่าไม่ให้ใช้อ้างอิง คาดว่าจะได้ข้อสรุปหลัง Executive Board เดือนมกราคม และ World Health Assembly ปีหน้า ที่ประชุมเห็นว่าโครงการไม่ได้ใช้ฉบับร่างเป็นเอกสารอ้างอิง แต่ใช้เป็นจุดตั้งต้นในการวิเคราะห์ช่องว่าง
- **ระดับของการ map** เนื่องจาก quality statements มีจำนวนมากและอาจไม่มีแหล่งข้อมูลรองรับครบ จึงควร map ถึงระดับ standard (34 standards) ก่อน ส่วน quality statement หรือ indicator ให้เลือกลงลึกเฉพาะประเด็นที่สนใจ เช่น model of care และ workforce
- **นิยามศัพท์** ต้องนิยามคำสำคัญให้ชัดเจนก่อน map เช่น “carer” หมายถึงใคร (ผู้ดูแลชาวไทยหรือชาวต่างชาติ) “workforce” ครอบคลุมเพียงใด (ทั้ง social care และ health care) และการดูแลในระดับ อบต. เพียงพอหรือไม่ รวมถึง institution-based care ซึ่งประเทศไทยยังมีน้อย (เช่น กรุงเทพฯ มีเพียงบ้านบางแคซึ่งคิวยาวมาก นอกนั้นเป็นของเอกชน)
- **รูปแบบการสกัดข้อมูล** ดร.รุ่งนภา เสนอทำ data extraction form แยกตาม standard ประกอบด้วยคอลัมน์ (1) standard (2) นิยาม/ความหมาย (3) หลักฐานของไทยที่ใช้ตอบ และ (4) สิ่งที่พบ ณ ปัจจุบัน ก่อนสรุปภาพรวมว่าข้อใดดีแล้ว ข้อใดยังมีข้อจำกัด

- ประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก (เช่น geriatrician) จึงอาจเสนอรายละเอียดหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก WHO ได้ แต่ยังไม่ต้องให้น้ำหนักในขั้นนี้

มติที่ประชุม (1) ไม่รอ Global Standards ฉบับสมบูรณ์ ให้ดำเนินการโดยใช้ฉบับร่างเป็นจุดตั้งต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังค่อยพิจารณาปรับ (2) map ถึงระดับ standard (34 standards) ส่วน quality statement/indicator ให้เลือกเฉพาะประเด็นที่สนใจภายหลัง (3) ดร.รุ่งนภา จัดทำ data extraction form (Excel) ส่งให้คณะผู้วิจัยพิจารณา (4) พญ.ณัฐณิชา ทบทวนนิยามศัพท์สำคัญและเอกสารใหม่ 2 ฉบับ

3.3 ผลการ explore WP3

นพ.นนทกร นำเสนอคำถามวิจัย 3 ข้อ ซึ่งเขียนในรูปแบบคำถามสำหรับ systematic review พร้อม review ที่สืบค้นได้เบื้องต้น และสอบถามว่าจำเป็นต้องลงทะเบียน PROSPERO หรือไม่ ได้แก่ Q1 need-based eligibility criteria, Q2 IMC → LTC transition และ Q3 non-cancer palliative care triggers ที่ประชุมให้ความเห็นดังนี้

- **Q1 และ Q2 ซ้อนทับกัน** จุดเข้าสู่ LTC จาก IMC ใช้เกณฑ์เดียวกับ Q1 จึงเป็น intersect ของ Q1 อยู่แล้ว ประกอบกับ Q2 ขึ้นกับบริบทประเทศไทยมาก (IMC ของไทยต่างจากต่างประเทศ เช่น กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) และอาจหาข้อมูลได้ยาก จึงไม่ถึงขั้นต้องทำ systematic review ให้รวมเป็นข้อเดียวกับ Q1
- **Q3** มี review ที่สังเคราะห์ systematic review ไว้แล้วประมาณ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ออนไลน์ปี 2025 ลงวารสารปี 2026) ถือว่าค่อนข้างใหม่ ไม่ต้องทำซ้ำ
- **กรอบคำถามของ Q1 (PECO)** ดร.รุ่งนภา แนะนำว่า P คือผู้ที่จำเป็นต้องได้รับ LTC โดยไม่จำกัดอายุ (รวมเด็กที่จำเป็นต้องได้รับ LTC), E คือเกณฑ์/เครื่องมือที่ใช้คัดเลือกผู้รับบริการเข้าสู่ LTC (ใช้ exposure แทน intervention), C ไม่มีก็ได้, O คือการ

ได้เข้าสู่ LTC และอาจรวม health outcome หลังเข้าสู่ LTC เพื่อบอกได้ว่าเกณฑ์นั้นดีหรือไม่

- **การตรวจสอบ search term** ให้หา primary study (งานที่พัฒนาและทดสอบ eligibility criteria) ประมาณ 5–10 เรื่องก่อน แล้วใช้ตรวจว่า search term สืบค้นพบงานเหล่านี้หรือไม่ เพื่อประเมินว่า search term มีความไว (sensitive) เพียงพอ ทั้งนี้ใช้ AI ช่วยได้ แต่ต้องเข้าใจหลักการ
- การเพิ่ม survey ผู้ให้บริการตามความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้รูปแบบการวิจัยของ WP3 เปลี่ยนจาก systematic review อย่างเดียว (รายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.2)

มติที่ประชุม (1) ทำ systematic review เฉพาะ Q1 โดยรวม Q2 เข้ากับ Q1 ส่วน Q3 ใช้ review ที่มีอยู่ (2) นพ.นนทกร ปรับคำถามวิจัยให้ครอบคลุมขึ้น ตั้ง PECO และหา primary study 5–10 เรื่อง ส่งปรึกษาในกลุ่มก่อน workshop (3) การลงทะเบียน PROSPERO ยังไม่ได้ข้อสรุป ให้พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 แนวทางตอบชี้แจงความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สวรส.

ที่ประชุมพิจารณาความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทีละข้อ และบันทึกแนวทางตอบลงในแบบตอบชี้แจง (ตัวอักษรสีแดง) สรุปดังนี้

หัวข้อ	ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ (สรุป)	แนวทางตอบชี้แจง/ปรับแก้
3. ชื่อโครงการ	เสนอเปลี่ยนชื่อเป็น “การพัฒนาต้นแบบระบบประเมินสิทธิประโยชน์ตามระดับความจำเป็น และกรอบการดูแลเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อตั้งแต่ระยะกลาง ระยะยาว จนถึงระยะสุดท้าย”	ปรับชื่อตามข้อเสนอแนะ และปรับหลักการและเหตุผล คำถามวิจัย ให้สอดคล้องกับชื่อใหม่
4. ลักษณะโครงการ	ความเห็นผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียวโดยไม่มีข้อมูลจริงรองรับอาจมีน้ำหนักไม่พอ	เพิ่มการ survey ผู้ให้บริการ (ระเบียบวาระที่ 4.2) เขียนเพิ่มว่าคณะผู้วิจัยเคยศึกษา

หัวข้อ	ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ (สรุป)	แนวทางตอบชี้แจง/ปรับแก้
	ควรสำรวจความคิดเห็นผู้ให้บริการ (survey)	สถานการณ์ไว้แล้ว (รายงาน UHC/IMC/LTC ปีที่แล้ว)
5. หลักการและเหตุผล	ปรับปรุงการเขียน	ปรับให้สอดคล้องกับชื่อใหม่
6. วัตถุประสงค์	เพิ่มข้อมูลสถานการณ์การให้บริการจริงในปัจจุบันเป็นฐานก่อนเข้า Delphi	ระบุว่าจะทบทวนสถานการณ์จากเอกสารที่มี ได้แก่ รายงานและ policy brief ของหน่วยจาก UHC Conference และรายงานของรามาธิบดี พร้อมแนบอ้างอิง
7. ทบทวนวรรณกรรม	มีหน่วยงานใดทำหรือตีพิมพ์เรื่องนี้แล้วบ้าง	มี แต่ไม่ครอบคลุมและไม่ตรงกับโครงการ เช่น รายงานของรามาธิบดีเป็น comprehensive report ที่ไม่ได้ตีพิมพ์ และเน้น financing และ design–implementation gap (รอ พญ.ณัฐณิชา สรุป gap เพิ่ม)
8. กรอบแนวคิด	ระบุ research question ที่ชัดเจน	ระบุ research question ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับชื่อใหม่
9.1 รูปแบบการวิจัย	หากไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณว่าหน่วยงานใดดำเนินการแล้วและได้ผลอย่างไร การใช้ Delphi อย่างเดียวจะไม่น่าเชื่อถือ	ทบทวนข้อมูลเชิงปริมาณที่หน่วยงานรัฐรายงานไว้ “เท่าที่เป็นไปได้” แล้วดึงจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น – สถาบันผู้สูงอายุ: จำนวนหน่วยที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน – ฐาน LTC ของ สปสช.: จำนวนผู้เข้าถึง/ลงทะเบียน (ปัจจุบันผู้ที่มี ADL < 11 ได้รับการดูแลผ่าน อปท.) – พม. (สวัสดิการ) และกระทรวงมหาดไทย
9.3 ความลำเอียง	ระบุมาตรการควบคุม selection/extraction bias (WP1), sampling bias (WP2) และ authority/peer	Selection bias: คัดเลือกแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่หาได้ ได้แก่ ฐานตีพิมพ์ของประเทศ (TCI/ThaiJO) รายงานของ สวรส. และ ThaiLIS

หัวข้อ	ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ (สรุป)	แนวทางตอบชี้แจง/ปรับแก้
	influence bias (Delphi)	(ฐานวิทยานิพนธ์) ใช้ข้อมูลที่ปรับปรุงไม่เกิน 5 ปี Sampling bias: ระบุผู้เข้าร่วมระดับองค์กร (เช่น อบจ., อปท.) โดยใช้รายชื่อจากงาน LTC ครั้งก่อนของ ดร.รุ่งนภา Authority bias: ใช้ anonymized feedback ใน Delphi รอบที่ 2 ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ
10. วิธีสังเคราะห์ policy option	ระบุวิธีสังเคราะห์ข้อมูลเป็น policy option	ร่าง policy option จากผลการทบทวนร่วมกับผล survey แล้วสัมภาษณ์เชิงลึกผู้กำหนดนโยบายจำนวนไม่มาก (ระบุระดับหน่วยงาน) เพื่อวิเคราะห์ว่า option ใดเป็นไปได้มากที่สุด แล้วสรุปเป็น possible policy option
11. การใช้ประโยชน์	ความเห็นทั่วไป	ไม่ต้องตอบ
12. ความเสี่ยง	ควรเพิ่มข้อมูลสถานการณ์และหลักฐานเชิงประจักษ์	อ้างอิงคำตอบข้อ 6 และ 9.1 คือได้จากการทบทวนวรรณกรรมร่วมกับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
13–15	เหมาะสม/เพียงพอ	ไม่ต้องตอบ
ข้อเสนอแนะท้ายแบบ	ควรเพิ่มการสำรวจข้อมูลจากผู้ให้บริการโดยการสุ่มตัวอย่าง	ไม่สุ่มตัวอย่าง เนื่องจากต้องปรึกษาสำนักงานสถิติแห่งชาติและงบประมาณไม่เพียงพอ ใช้การส่งแบบสำรวจให้ครอบคลุมทุกระดับบริการแทน (ระเบียบวาระที่ 4.2)

ประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม

- **ข้อมูลเชิงปริมาณ (ข้อ 9.1)** WHO Standards ครอบคลุมกว้างกว่าการคัดกรองโรค (health care facility, LTC facility, unpaid carers, governance, monitoring และ financing) การ

survey ถามหน่วยบริการว่า “ได้ทำเรื่องนี้หรือไม่” เป็นข้อมูลที่ตอบเองและตรวจสอบไม่ได้ จึงควรใช้ข้อมูลที่มีการรายงานไว้แล้ว ระบบ LTC ปัจจุบันของไทยเน้นผู้ที่มี ADL < 11 ผ่าน อปท. หากต้องการตัวเลขควรนับจากฐานข้อมูล สปสช. ส่วนฐานข้อมูลของ อปท./อบจ. คาดว่าไม่มีหรือเข้าถึงได้ยาก

- ให้ WP1 นำ standards มาพิจารณาร่วมกันว่าแต่ละข้อมีข้อมูลเชิงปริมาณใดตอบได้ ซึ่งอาจตอบได้เพียงบางข้อ
- **WP1 ไม่ใช่ systematic review** แต่เป็นการนำข้อมูลที่มีอยู่มา match กับมาตรฐาน โดยผู้วิจัยพิจารณาความถูกต้องของการ match ข้อมูลที่เก่าเกิน 5 ปีจะไม่นำมาใช้ เนื่องจากระบบเปลี่ยนแปลงตลอด และงานในบริบทท้องถิ่นมักนำมาใช้ได้ยาก
- **ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก (ข้อ 10)** ระบุระดับหน่วยงานก็เพียงพอ ได้แก่ ราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง กรมในกระทรวงสาธารณสุข (เช่น กรมการแพทย์) และหน่วยงานจัดซื้อบริการ (เช่น สปสช.) ทั้งนี้ต้องมี policy option ก่อนจึงไปสัมภาษณ์
- ความละเอียดของการระบุผู้เข้าร่วมขึ้นกับผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน ครั้งนี้ควรระบุเป็นรายองค์กร

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางตอบชี้แจงตามตาราง ให้ปรับแก้แบบตอบชี้แจงและข้อเสนอโครงการ แล้วส่งให้คณะผู้วิจัยพิจารณาภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2569

4.2 การเพิ่มการสำรวจความคิดเห็นผู้ให้บริการ (survey)

ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ และพิจารณารายละเอียดดังนี้

- **ช่วงเวลา** ทำหลังจากได้เกณฑ์จากการทบทวนวรรณกรรมแล้ว โดยส่งร่างเกณฑ์ให้ผู้ให้บริการพิจารณาว่าเห็นด้วยและทำได้หรือไม่ (ไม่ใช่ survey ก่อนการทบทวน)
- **เนื้อหา** เน้นเกณฑ์ทั้งการเข้าและออกจาก LTC รวมถึงเกณฑ์และรูปแบบการส่งต่อ มากกว่าการประเมินสถานการณ์ เนื่องจากหากให้ผู้ให้บริการประเมินทั้ง framework อาจไม่เห็นภาพรวม

- **กลุ่มเป้าหมาย** ผู้ให้บริการระดับชุมชน (อบต./อปท.) ร่วมกับโรงพยาบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งต่อผู้ป่วยที่อาการมากขึ้น
- **แทน stakeholder meeting** survey ใช้แทนการประชุม stakeholder ใน WP3 เนื่องจากการประชุมอาจได้ผู้เข้าร่วมเพียงบางกลุ่ม (selective) ขณะที่ survey ให้หลักฐานที่มีน้ำหนักกว่า
- **Response rate** คาดว่าไม่สูง (ประมาณ 20% ถือว่าดีแล้ว) แนวทางคือขอความร่วมมือกรมการแพทย์และสถาบันผู้สูงอายุช่วยส่งแบบสำรวจ เนื่องจากมีบทบาทกำกับหน่วยบริการ จึงน่าจะได้ response ดีกว่า (แลกเปลี่ยนกับการที่คณะผู้วิจัยช่วยงานของหน่วยงาน) และส่งผ่านเครือข่ายโครงการต่าง ๆ ของคณะผู้วิจัย
- **การสุ่มตัวอย่าง** ไม่สุ่ม แต่ส่งให้ครอบคลุมตามระดับบริการ (level of service) เช่น โรงพยาบาลขนาดต่างกันประมาณ 15 แห่ง และหน่วยบริการระดับชุมชน (รพ.สต./อบต.) แล้วพิจารณาตาม response ที่ได้

มติที่ประชุม เพิ่ม survey ผู้ให้บริการใน WP3 หลังได้ร่างเกณฑ์จาก systematic review โดยไม่สุ่มตัวอย่าง และให้ปรับรูปแบบการวิจัยของ WP3 ในข้อเสนอโครงการ (systematic review + survey) ประธานและ อ.วราลักษณ์ ประสานกรมการแพทย์และสถาบันผู้สูงอายุเรื่องการส่งแบบสำรวจ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 Workshop การสร้าง search strategy สำหรับ WP3

ดร.รุ่งนภา จะสอนการสร้าง search term แบบ workshop โดยทดลองทำจริงกับคำถามของ WP3 ผู้รับผิดชอบ WP3 เตรียม PECO และ primary study 5–10 เรื่องมาก่อน เปิดให้แพทย์ใช้ทุนและน้อง ๆ ในทีมของประธานเข้าร่วมได้ และบันทึกการประชุมไว้ให้ผู้ที่เข้าร่วมไม่ได้

มติที่ประชุม จัด workshop วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569 เวลา 09.00–12.00 น. (เวลาประเทศไทย) แบบออนไลน์

5.2 แหล่งสืบค้นวรรณกรรมของประเทศไทย

หลังการประชุม ดร.รุ่งนภา ส่งลิงก์ฐานข้อมูลที่กล่าวถึงในระเบียบวาระที่ 4.1 (ข้อ 9.3) ได้แก่ ThaiLIS Digital Collection (https://tdc.thailis.or.th/) สำหรับวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของไทย และ TCI ThaiJO (https://www.tci-thaijo.org/) สำหรับวารสารวิชาการไทย

มติที่ประชุม รับทราบ ใช้เป็นแหล่งสืบค้นของ WP1 และระบุในแบบตอบชี้แจง

5.3 กำหนดการประชุมครั้งถัดไป

ประชุมครั้งถัดไปเพื่อรายงานผลการสืบค้นหลัง workshop วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคมตรงกับวันปิยมหาราช จึงคงเป็นวันพฤหัสบดีและเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้น

มติที่ประชุม กำหนดประชุมครั้งถัดไป วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2569 เวลา 15.00–16.00 น.

เลิกประชุมเวลาประมาณ 12.00 น.

สรุปงานที่ได้รับมอบหมาย

ที่	ผู้รับผิดชอบ	งาน	กำหนดส่ง
1	หม่อน, อ.หฤษฎ์	ปรับแก้แบบตอบชี้แจงผู้ทรงคุณวุฒิและข้อเสนอโครงการตามระเบียบวาระที่ 4 (ชื่อ, หลักการ, RQ, ข้อมูลเชิงปริมาณ, bias, survey, policy option)	11 ต.ค. 2569
2	พี่เมจิ	สรุป gap ของรายงานเดิม (SiHP, รามาธิบดี) เทียบกับโครงการ เพื่อตอบข้อ 7 ทบทวนวรรณกรรม	11 ต.ค. 2569
3	ดร.รุ่งนภา	ส่งรายชื่อองค์กรผู้เข้าร่วมจากงาน LTC ครั้งก่อน สำหรับตอบเรื่อง sampling bias	11 ต.ค. 2569
4	หม่อน	ปรับคำถามวิจัย WP3 (รวม Q2 เข้า Q1) ตั้ง PECO และหา primary study 5–10 เรื่อง ส่งปรึกษาในกลุ่ม	ก่อน 15 ต.ค. 2569
5	ดร.รุ่งนภา, หม่อน	Workshop การสร้าง search strategy (ออนไลน์ บันทึกไว้)	15 ต.ค. 2569 09.00–12.00 น.
6	หม่อน	ทดลองสืบค้นด้วย search term ที่ได้ และรายงานจำนวนผลการสืบค้น	22 ต.ค. 2569
7	หม่อน	แก้ไขแผนภาพ workflow ให้ WP1–2 และ WP3 เป็นสายงานแยกกัน	22 ต.ค. 2569
8	ดร.รุ่งนภา	จัดทำ data extraction form (Excel) สำหรับ WP1 และส่งให้คณะผู้วิจัย	ก่อน 22 ต.ค. 2569
9	พี่เมจิ	Map WP1 ระดับ standard (34 standards) นิยามศัพท์สำคัญ (carer, workforce ฯลฯ) และทบทวนเอกสาร สปสช. (เม.ย.) และเอกสารการจ่ายค่าตอบแทน caregiver (ก.ย.)	22 ต.ค. 2569

ที่	ผู้รับผิดชอบ	งาน	กำหนดส่ง
10	อ.วราลักษณ์	อ่าน standards และเลือก quality statement/indicator ที่ต้องการลงลึก (เช่น model of care, workforce)	22 ต.ค. 2569
11	อ.หฤษฎ์, อ.วราลักษณ์	ประสานกรมการแพทย์และสถาบันผู้สูงอายุเรื่องการส่งแบบสำรวจผู้ให้บริการ	ดำเนินการต่อเนื่อง
12	คณะผู้วิจัย	พิจารณาการลงทะเบียน PROSPERO สำหรับ systematic review ของ WP3	ประชุม 22 ต.ค. 2569